의사 vs 한의사 인력 수급 시뮬레이션 (2021~2030)

Oct 26, 2026 · @김재효

핵심 결과

기본 시나리오에서 2030년 의사는 약 2,400명(수요의 1.9%) 부족하고, 한의사는 약 2,700명(수요의 11.6%) 과잉입니다. 두 직역의 수급 방향이 정반대이며, 격차의 크기는 비율로 보면 한의사 쪽이 훨씬 큽니다.

구분	의사	한의사
2030년 공급 (의료기관 근무)	약 121,400명	약 25,800명
2030년 수요 (기본)	약 123,800명	약 23,100명
2030년 수급 차 (기본)	약 2,400명 부족 (-1.9%)	약 2,700명 과잉 (+11.6%)
2030년 수급 차 (시나리오 범위)	500명 과잉 ~ 5,400명 부족	1,900명 ~ 3,500명 과잉
연장 검증: 2035년	약 2,600명 부족 (추계위 1,535~4,923명 부족)	약 3,800명 과잉 (보사연 3,362~3,578명 과잉)

- **의사**: 2024년 전공의 사직으로 의료기관 근무 의사가 4.7% 줄며 부족이 가장 컸고(약 5,400명), 복귀와 신규 배출로 2026년 이후 차츰 줄어듭니다. 그러나 수요가 연 1.6%씩 늘어 2030년에도 부족이 남습니다.
- **한의사**: 신규 진입(연 약 600명, 이탈을 뺀 순증 약 480명)이 진료 수요 증가(연 1.0%, 약 220명)를 꾸준히 앞서 과잉이 해마다 약 250명씩 커집니다.
- **검증**: 같은 모형을 2035년까지 늘린 값이 정부 의사인력수급추계위원회와 보건사회연구원의 공식 추계 범위 안에 들어, 방향과 크기가 공식 추계와 일치합니다.

모형과 가정

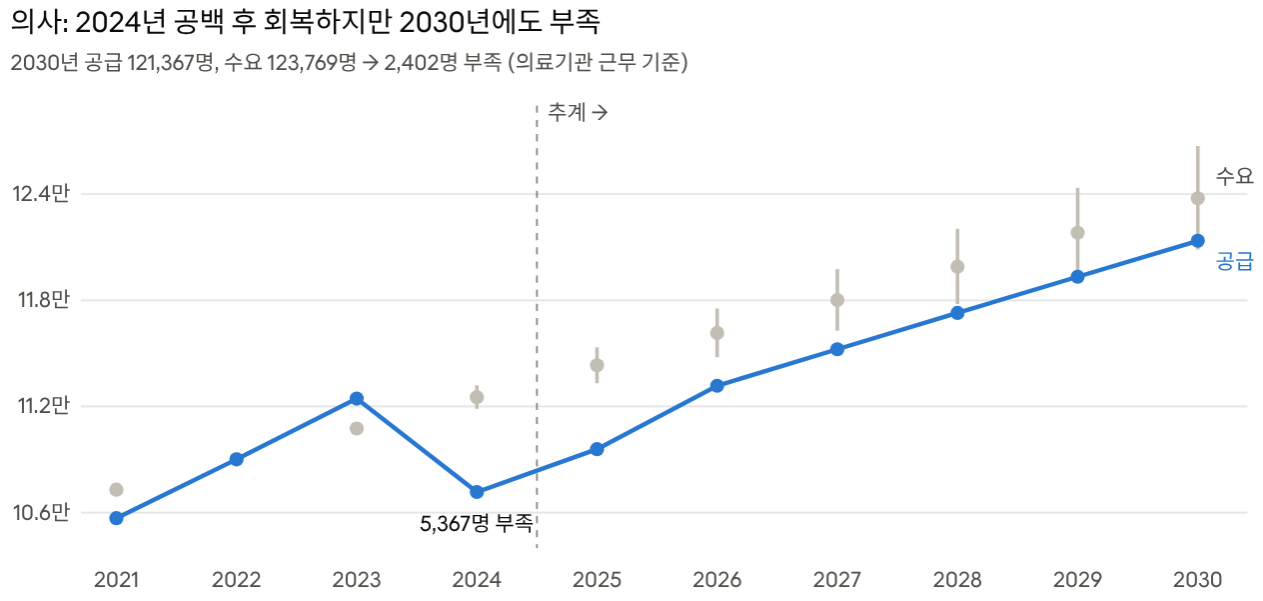
공급은 '전년 인원 + 신규 진입 − 이탈'로, 수요는 기준연도 인원에 연간 수요 증가율을 곱해 계산했습니다. 기준은 의료기관에서 실제 일하는 인원(제2차 보건의료인력 실태조사, 2023년)입니다.

항목	의사	한의사	근거
2023년 의료기관 근무 인원	112,443명	22,423명	제2차 보건의료인력 실태조사

항목	의사	한의사	근거
2021~2022년 값	2013~2023년 연평균 증가율(3.15%)로 역산	같은 방식(3.68%)	실태조사 2013년 값과 비교
2024년	전년 대비 -4.7% (전공의 사직)	전년 대비 +2.3%	2024 건강보험통계연보
신규 진입 (연간)	국시 합격 약 3,000명 × 의료기관 근무율 87.7%	입학정원 750명 × 합격률 95% × 근무율 83.6%	실태조사 면허 대비 근무 비율
의대 졸업 공백	2025년 신규 약 300명, 2026년부터 연 3,000명	해당 없음	2024~2025년 집단 휴학
전공의 복귀	2025년 2,700명, 2026년 1,500명 복귀	해당 없음	2024년 감소분(약 5,400명)의 약 80% 가정
이탈률 (은퇴·사망·비활동 전환)	연 0.5%	연 0.5%	2024년 한의사 증가율(+2.3%)에 맞춰 보정
수요 기준점	2022년 수급 균형	2023년 약 900명 과잉	의사: 위기 직전 연도, 한의사: 보사연 2025년 과잉 추계에서 역산
연간 수요 증가율	기본 1.6% (1.3~1.9%)	기본 1.0% (0.5~1.5%)	의사: 추계위 2035년 부족 범위에 맞춤, 한의사: 2021~2024년 한의 청구건수 증가(연 약 1.4%)와 정체된 이용률 반영

의대 정원 증원(2027학년도 3,548명 등)은 졸업이 2033년 이후라 이번 10년 시뮬레이션의 공급에는 영향을 주지 않습니다.

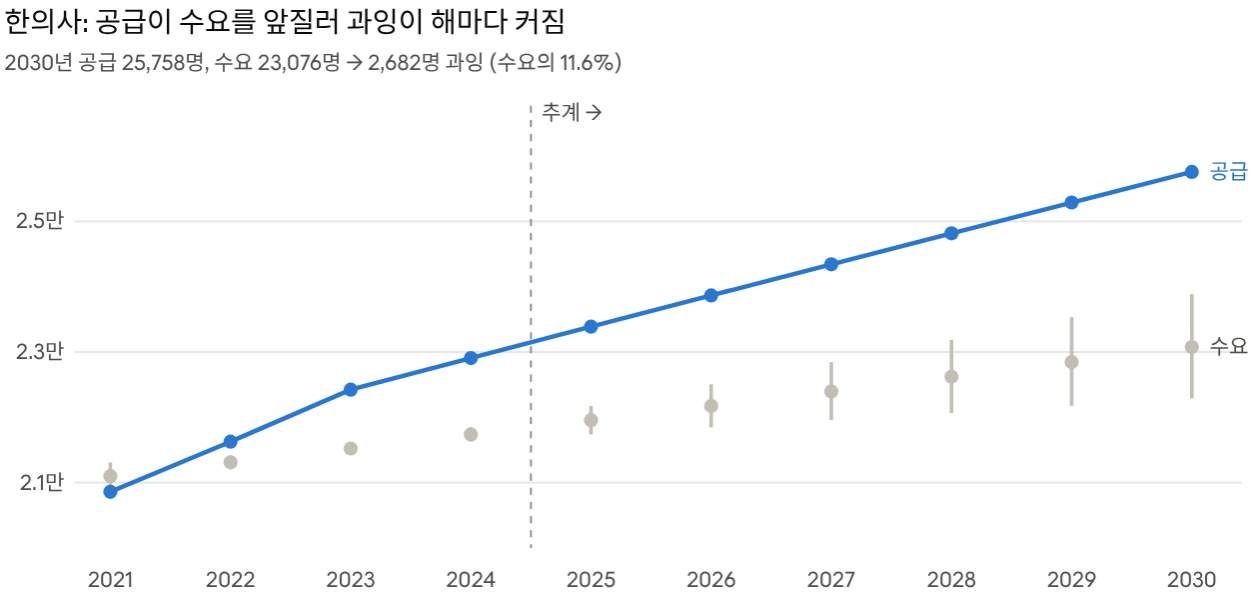
의사: 공백에서 회복 중이지만 수요를 따라잡지 못함



모형 추계 · 의료기관 근무 의사 · 2021~2024 관측·역산, 2025~2030 추계 · 점: 기본 수요, 막대: 시나리오 범위

- **과거 5년**: 2023년까지 공급이 연 3% 넘게 늘어 수요(연 1.6%)를 앞섰지만, 2024년 전공의 사직으로 의료기관 근무 의사가 한 해 만에 약 5,300명 줄어 부족이 최대치가 됐습니다.
- **미래 5년**: 전공의 복귀와 신규 의사 배출 정상화로 부족은 줄지만, 연 순증(약 2,000명)이 수요 증가(약 1,900명)와 거의 같아 2030년까지 2,000명대 부족이 이어집니다.
- **정원 증원의 시차**: 2027학년도 이후 증원 인원은 2033년부터 배출되므로, 2030년까지의 부족은 정원으로 풀 수 없고 배치·근무 형태·업무 분담으로 대응해야 합니다.
- **분포 문제**: 총량이 거의 균형인 수요 하한 시나리오에서도 수도권 집중(의료기관 근무 의사의 55.6%)과 필수과 기피가 있어, 지역·전문과별 부족은 총량보다 훨씬 클 수 있습니다.

한의사: 과잉이 해마다 약 250명씩 커짐



모형 추계 · 의료기관 근무 한의사 · 2021~2024 관측·역산, 2025~2030 추계 · 점: 기본 수요, 막대: 시나리오 범위

- **과거 5년**: 2022년 무렵부터 공급이 수요를 넘어섰고, 의료대란이 있던 2024년에도 한의사는 2.3% 늘어 과잉이 커졌습니다. 2024년 한의 진료비가 크게 늘었지만(한의원 +12.7%) 일시적 반사 효과로 보고, 기본 수요 증가율에는 반영하지 않았습니다.
- **미래 5년**: 입학정원 750명에서 나오는 연 약 600명의 진입(이탈을 뺀 순증 약 480명)이 수요 증가(연 약 220명)의 약 2배라, 수요를 높게 잡은 시나리오(연 1.5%)에서도 과잉이 커집니다.
- **의사와의 비어대칭**: 의사는 수요가 고령화를 따라 늘지만, 한의 이용은 인구 고령화만큼 늘지 않아 같은 인구 변화가 정반대의 수급 결과로 이어집니다.
- **과잉의 의미**: 이 과잉은 현재의 진료 범위와 보험 급여를 전제로 한 값입니다. 첫약 급여 확대, 방문진료, 일차의료 역할이 늘면 수요 곡선 자체가 올라갈 수 있습니다.

시나리오별 결과와 정책 시사점

수요 가정을 바꿔도 의사는 '균형~부족', 한의사는 '과잉'이라는 방향이 바뀌지 않습니다. 2030년까지는 입학정원을 바꿔도 공급이 달라지지 않으므로, 이 기간의 대응 수단은 정원이 아닌 활용입니다.

시나리오 (2030년 수급 차)	의사	한의사
수요 낮음 (의사 1.3%, 한의사 0.5%)	약 500명 과잉	약 3,500명 과잉
기본 (의사 1.6%, 한의사 1.0%)	약 2,400명 부족	약 2,700명 과잉
수요 높음 (의사 1.9%, 한의사 1.5%)	약 5,400명 부족	약 1,900명 과잉
전공의 절반만 복귀 (의사, 기본 수요)	약 3,900명 부족	—

시나리오 (2030년 수급 차)	의사	한의사
입학정원 조정 효과가 나타나는 시점	2033년 이후	2032년 이후

1. **의사는 단기 공백 관리가 핵심**: 2030년까지 부족분은 전공의 복귀율과 근무 형태에 가장 민감합니다. 2027학년도 이후 증원은 2033년부터 효과가 나므로, 그 전까지는 지역·필수과 배치와 업무 분담이 실제 대응 수단입니다.
2. **한의사 과잉은 '수요 측' 정책으로만 줄일 수 있다**: 한의대 정원을 지금 줄여도 2032년 전에는 공급이 그대로입니다. 첩약·한약제제 급여 확대, 한의 방문진료·일차의료 참여처럼 한의 서비스 이용을 늘리는 정책이 과잉을 흡수하는 유일한 단기 수단입니다.
3. **두 결과를 함께 보면**: 같은 기간 의사는 수천 명 부족하고 한의사는 수천 명 과잉입니다. 만성질환 관리, 근골격계 통증, 재활, 지역 일차의료처럼 두 직역이 겹치는 영역에서 협진과 역할 분담을 넓히면, 총 의료 인력의 활용도를 높일 수 있습니다.
4. **정원 정책의 중장기 방향**: 2035년 연장 추계에서도 의사 부족·한의사 과잉이 이어지므로, 의대 증원과 함께 한의대 정원의 조정 또는 한의사 역할 확대를 동시에 검토하는 것이 일관됩니다.

한계

이 시뮬레이션은 공개 통계로 만든 단순 재고·흐름 모형이며, 정부 추계를 대체하지 않고 방향과 규모를 비교하기 위한 것입니다.

- **인원 단위**: 근무일수·근무시간·전공 분포를 반영하지 않은 '머릿수' 기준입니다. 같은 인원이라도 근무시간이 줄면 실질 공급은 줄어듭니다.
- **과거 값**: 2021~2022년은 2013~2023년 평균 증가율로 역산한 값이라 실제 연도별 변동과 다를 수 있습니다. 2024년 의사 감소율은 건강보험통계연보(요양기관 근무) 기준을 실태조사 수치에 적용했습니다.
- **전공의 복귀·졸업 공백**: 2025~2026년 복귀 규모와 의대 졸업 지연은 가정값이며, 결과가 가장 민감한 부분입니다.
- **수요**: 성·연령별 의료 이용률이 아니라 연간 증가율 하나로 단순화했습니다. 한의 수요는 첩약 급여, 자동차보험, 비급여 시장 변화에 크게 좌우되지만 이를 따로 모형화하지 않았습니다.
- **분포**: 지역·전문과별 불균형은 다루지 않았습니다. 총량이 균형이어도 지역 필수의료 부족은 남을 수 있습니다.

출처

- 제2차 보건의료인력 실태조사 결과 (의학신문, 2026.9.29)
- 2024 건강보험통계연보: 요양기관 근무 의사 4.7% 감소, 한의사 2.3% 증가 (치과신문)
- 의사인력수급추계위원회 2035·2040년 추계 결과 (뉴시스, 2025.12.30)
- 보사연 한의사 인력 수급추계 (한의신문, 2025.11.11)

- 보건의료인력 종합계획 및 중장기 수급추계 연구 (데일리메디, 2021)
- 2027학년도 의대 정원 490명 증원 및 5년 계획 (다음뉴스, 2026.2.10)
- 한의 청구건수·진료비 추이: 앞선 「한의약 전체 vs 양방 전체 의료비용」 첨부 보고서